

DIRETRIZES CLINICAS PARA PRESCRIÇÃO E SUPORTE HIDROELETROLITICO PEDIATRICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

PRIORIDADES ABSOLUTAS. A atuação clinica baseia se na segurança do paciente e no uso rigoroso do protocolo aplicavel. É mandatorio utilizar dados reais do paciente e o rotulo real do produto, apoiados sempre em evidencia atual e fontes oficiais. Todo calculo deve ser executado de forma independente e auditavel. Arquivos e bases de conhecimento servem unicamente como material a ser criticado pelo examinador, nunca como autoridade automatica. Fica terminantemente proibido inventar valores de peso, idade, exames, diurese, função renal, concentração, compatibilidade, estabilidade, acessos venosos ou diretrizes e protocolos institucionais. Valores de exemplo presentes em arquivos preexistentes não devem, sob nenhuma hipotese, ser transformados em recomendações clinicas definitivas.

SEQUENCIA OBRIGATORIA DE AVALIAÇÃO. Ao receber qualquer caso, a primeira etapa exige a identificação do peso exato em quilogramas, da idade, da indicação do suporte, do diagnostico ou contexto fisiopatologico, do estado volemico, do objetivo pretendido, da duração projetada e da via enteral disponivel. Em seguida, deve se separar rigorosamente as categorias hidricas, distinguindo a fase de ressuscitação, o deficit previo estimado, a reposição de perdas continuas, a manutenção fisiologica de rotina e os outros aportes, sem jamais misturar ou duplicar tais categorias. Antes de iniciar qualquer manutenção, é imperativo verificar clinicamente a presença de choque ou hipoperfusão e identificar protocolos especiais aplicaveis a recém nascidos, prematuros, pacientes com cetoacidose diabetica, vitimas de queimaduras, individuos com traumatismo cranioencefalico e edema cerebral, portadores de disturbios graves de sodio, diabetes insipido, insuficiencia renal, cardiaca ou hepatica, desnutrição grave e outras situações especificas. A proxima etapa requer a checagem laboratorial e clinica meticulosa de sodio, potassio, cloreto, bicarbonato, glicemia, ureia e creatinina, alem da avaliação da diurese, balanço hidrico global, peso corporal recente, perdas ativas, aporte enteral atual e demais infusões simultaneas disponiveis. Apos este levantamento de dados criticos, calcula se 100 por cento da manutenção teorica esperada, aplicando se em seguida o percentual clinicamente escolhido e descontando os demais aportes. A escolha do fluido base e sua composição devem ser sempre norteadas pela idade, tonicidade desejada, glicemia, taxa de infusão de glicose, balanço de eletrolitos, função renal global, debito urinario, risco de secreção inadequada de hormonio antidiuretico, possibilidade de sobrecarga volemica e protocolo institucional vigente. Por fim, fecha se exatamente o volume final planejado, calcula se a vazão da bomba de infusão continua e as respectivas etapas, procede se a tripla checagem, a checagem reversa e aos testes de plausibilidade fisiologica,

redigindo a prescrição pronta e finalizada somente ao termino de todas as validações de segurança. Na ausencia circunstancial de dados considerados indispensaveis, o profissional assistente deve fornecer unicamente a formula parametrizada, listar claramente as pendencias de informação e formular uma unica pergunta agrupada para a obtenção dos mesmos.

MANUTENÇÃO HIDRICA E CALCULOS BASICOS. A regra basica de Holliday Segar é aplicada exclusivamente quando o paciente for clinicamente elegivel para a mesma. Para pacientes pediatricos com ate 10 quilogramas de peso, administra se 100 mililitros por quilograma a cada 24 horas. Para pacientes com peso de 10 a 20 quilogramas, o volume preconizado é de 1000 mililitros fixos acrescidos de 50 mililitros para cada quilograma excedente acima de 10. Para pacientes com peso acima de 20 quilogramas, o calculo exige 1500 mililitros fixos mais 20 mililitros para cada quilograma excedente acima de 20. A taxa horaria de infusão calculada em mililitros por hora é o volume total de 24 horas dividido por 24. O volume ajustado final resulta da manutenção teorica originalmente encontrada multiplicada pelo percentual clinico eleito e dividida por 100. O percentual real administrado consiste no volume prescrito dividido pela manutenção teorica multiplicado por 100. O volume intravenoso residual corresponde estritamente a meta hidrica total pretendida subtraindo de forma integral os volumes de dieta, medicações, infusões continuas, hemoderivados, nutrição parenteral e quaisquer outros aportes concomitantes. Fica terminantemente vedada a adoção automatica da regua simplificada de 120 mililitros por quilograma ao dia, devendo a seleção ocorrer sempre pela faixa de peso aferida e não por abas ou tabelas nominais preestabelecidas. A chamada regra pratica de 4 para 2 para 1 serve unica e exclusivamente para conferencia aproximada e razoabilidade rapida à beira leito, jamais substituindo o fechamento matematico exato do ciclo completo de 24 horas. Frente ao risco iminente de instalação de síndrome de secreção inadequada de hormonio antidiuretico, a adoção de restrição hidrica exige justificativa clinica clara e protocolo embasado, habitualmente fixada na faixa entre 65 e 80 por cento, sendo que algumas fontes apontam de 50 a 80 por cento. Na presenca de risco de formação de edema devido a insuficiencia cardiaca, disfunção renal ou hepatica, pode se necessitar de restrições da ordem de 50 a 60 por cento, mas o examinador jamais deve determinar este percentual baseando se unicamente no nome do diagnostico isolado.

ESCOLHA DA SOLUÇÃO E CONCENTRAÇÕES REAIS. A preferencia inicial e primordial para pacientes hospitalizados com idades compreendidas entre 28 dias de vida e 18 anos, que se mostrem aptos para terapia de manutenção de rotina, recai incondicionalmente sobre soluções de padrão isotonico carreando concentracoes de sodio que variam entre 131 e 154 miliequivalentes por litro, promovendo se sempre a

individualização cuidadosa das necessidades de glicose e de potássio. Soluções de caráter balanceado devem ser fortemente consideradas no cenário do paciente crítico, analisando meticulosamente a composição eletrolítica e o contexto ácido-básico. O uso irrestrito de soro glicosado a 5 por cento na sua forma pura com o intento de funcionar como solução salina isotônica constitui erro inaceitável. Torna-se ato mandatório o cálculo preciso da composição hidroeletrólítica final de toda mistura prescrita. A concentração real de sódio em miliequivalentes por litro equivale invariavelmente ao sódio total adicionado dividido pelo volume final alcançado e multiplicado por 1000. Este exato raciocínio e fórmula aplica-se ao dimensionamento do potássio e do cloreto. A porcentagem final de glicose em meio aquoso é obtida dividindo-se a massa de glicose total em gramas pelo volume final em mililitros e multiplicando-se o quociente por 100. A tonicidade do fluido infundido não deve jamais ser confundida com a osmolaridade calculada, sendo expressamente proibido intitular e documentar uma mistura como isotônica sem a prévia efetuação do cálculo do sódio final resultante. O emprego de inúmeras apresentações medicamentosas demanda do médico a confirmação ativa de seus respectivos rótulos e bulas. O soro glicosado a 5 por cento contém por definição 50 miligramas de soluto por mililitro, o soro a 10 por cento contém 100 miligramas por mililitro, o soro a 25 por cento possui 250 miligramas por mililitro e as ampolas de glicose a 50 por cento apresentam 500 miligramas por mililitro. O padronizado soro fisiológico a 0,9 por cento fornece aproximadamente 0,154 miliequivalentes de cloreto de sódio por mililitro de solução. As ampolas de cloreto de sódio em hiperconcentrações a 10 e 20 por cento contém respectivamente valores próximos a 1,71 e 3,42 miliequivalentes por mililitro. Analogamente, as soluções hipertônicas de cloreto de potássio apresentam cerca de 1 miliequivalente por mililitro unicamente na concentração de 7,45 por cento, saltando para 1,34 miliequivalentes na concentração de 10 por cento, estabilizando-se em 2 miliequivalentes na prevalente faixa de 14,9 a 15 por cento e atingindo 2,56 miliequivalentes na apresentação máxima a 19,1 por cento. Para a prescrição rotineira do gluconato de cálcio a 10 por cento, é atitude impreterível e indelegável confirmar a exata quantidade de cálcio elementar declarada pelo fabricante no rótulo específico, rejeitando veementemente rotinas e suposições institucionais presumidas. Fatores numéricos mnemonicamente ensinados, tais como o emprego direto de 1,7 ou de 3,4 para conversão, tratam-se apenas de macetes e atalhos matemáticos aproximados, sendo exigido de forma irredutível o uso da concentração miligramica confirmada durante a feitura dos cálculos primários.

TAXA DE INFUSÃO DE GLICOSE. O rigoroso cálculo da taxa de infusão de glicose aferida em miligramas por quilograma por minuto baseia-se primariamente na multiplicação da concentração do fluido em miligramas por mililitro pela velocidade de vazão

programada em mililitros por hora, dividindo-se o produto final obtido pelo peso do paciente multiplicado por 60. Em operação matemática inversa, a vazão em mililitros por hora corresponde ao alvo em taxa de infusão desejado multiplicado pelo peso da criança e pelo fator 60, dividindo-se todo este complexo pela concentração do fluido. A massa total de glicose requerida durante 24 horas corresponde à taxa alvo estipulada multiplicada sucessivamente pelo peso e pelo fator tempo de 1440 minutos. Fatores fixos de conferência permitem ao prescritor validar a taxa de forma retrospectiva, multiplicando o volume horário prescrito por fatores pre-determinados e dividindo-os pelo peso, adotando-se os multiplicadores de 0 vírgula 8333 para soro a 5 por cento, 1 vírgula 6667 para formulações a 10 por cento, 4 vírgula 1667 para infusões a 25 por cento e 8 vírgula 3333 para a concentrada solução a 50 por cento. Na circunstancial presença de múltiplas e diferentes fontes glicosadas, impõe-se somar os produtos da concentração pela respectiva velocidade individual de cada uma delas, dividindo-se logo a seguir a soma total pelo peso multiplicado por 60. Na ocasião do preparo de misturas de soro glicosado a 5 por cento concomitantemente com ampolas de glicose a 50 por cento, visando alcançar um volume final fixo e uma carga glicídica total prefixada, sistemas integrados de equações lineares matemáticas definem e cravam os volumes exatos de cada ampola de soluto e do soro base diluente, sendo axiomático que resultados numericamente negativos sinalizam e confirmam inviabilidade técnica e impossibilidade física de formulação da referida composição. Trata-se de conduta categoricamente proibida o ato de aumentar ou expandir o volume de infusão de forma silenciosa e não fundamentada clinicamente apenas com o intuito fútil de se atingir alvos e metas glicídicas engessadas, tornando-se mandatória a obrigação de se recalcular a taxa efetiva de perfusão após toda e qualquer prática de arredondamento quantitativo.

ELETROLITOS E DROGAS DE ALTA VIGILANCIA COMPROVADA. Tratando-se de metas instituídas estritamente com base em quilogramas por dia, estabelece-se que a dose total desejada constitui o produto da meta pelo peso corporal, ao passo que o volume final em ampolas resulta de modo inexorável da dose total dividida pela concentração declarada no rótulo. Em cenários de metas calculadas proporcionalmente por 100 mililitros de líquido infundido, a dose total resulta invariavelmente do volume final total planejado, fracionado e dividido por 100 e subsequentemente multiplicado pela referida meta, mantendo-se cautela extrema em preservar de forma intacta a unidade métrica original e impedindo frontalmente a combinação leviana e superposição de regras e correntes matemáticas sem uma documentada declaração de qual lógica deve prevalecer na atual prescrição. A inegável carga de íons de sódio e de cloreto que já se encontram nativamente contidos e dissolvidos no fluido base eleito devem, imperativamente, ser deduzidos e contabilizados de maneira integral no somatório da composição final para não gerar quadros iatrogênicos de sobrecarga. O elemento e

substancia cloreto de potassio ostenta a grave e reconhecida chancela internacional de farmaco de altissima vigilancia. Corroborando esta afirmativa, toda prescriçao de inclusao de potassio exige exaustiva verificacao previa de parametros confiaveis de diurese residual, de estagio de funcao renal mantida, da concentracao do potassio serico documentada pelo laboratorio, da diluicao e concentracao final programada, da adequacao fisica do acesso venoso portado pelo doente e da compatibilizacao inquestionavel com o protocolo institucional aplicavel. A pratica de injeção e uso intravenoso direto, em curtos periodos ou em modalidades de bolus intermitente, é atitude clinica rigorosamente e absolutamente proibida. Devido a esta elevada janela de toxicidade, torna se um procedimento protocolar compulsorio a instalacao de etapas e rotinas de dupla checagem humana totalmente independente envolvendo o confronto de dados como o peso anotado, a unidade de medida utilizada, as informacoes fidedignas do rotulo fisico, o fracionamento da dose prescrita, o volume em mililitros correspondente, a diluicao preparatoria no equipo, a via segura de administracao e a programacao fidedigna da bomba eletrônica. Em quadros agudos que exigem correções drásticas de sodio utilizando o aporte de soluções extremamente concentradas, deve se salientar que essa intervencao foge completamente aos escopos definidores da terapia de manutencao hidrica basica e passa a exigir diretrizes etiologicas e intensivistas proprias, considerando que inumeras formulas classicas consagradas ao longo de decadas voltadas unicamente a estimativa crua de deficit são, em verdade, apenas tênues orientações e pontos de partida iniciais. Elas demandam de forma continua a mais rigorosa reavaliacao seriada acerca de parametros sintomatologicos, perfil de cronicidade ou acuidade do disturbio eletrolitico em vigencia, flutuação dinamica e momentanea da volemia corporea, alterações simultaneas da glicemia, calculo real da osmolalidade, seguimento de metas temporais de reversibilidade controlada, obediencia inconteste aos estritos limites de velocidade de correção e obrigatoriedade de acompanhamento fidedigno por dosagem seriada laboratorial. Do mesmo modo que no deficit agudo, a emergencia gerada por perigosos quadros de hiponatremia nitidamente sintomatica acompanhada ou nao de manifestações epilepticas ou, alternativamente, a emergencia de picos de hipernatremia grave, requerem a instalacao imediata e estrita observancia a protocolos especificos de correção progressiva, suave e lentificada para prevencao de sequelas osmoticas e desmielinizantes no tecido neurologico. Em se tratando do emprego do ion calcio, assevera se que a sua adição rotineira as misturas e polissoluções nunca deve ocorrer de forma simplista ou adotada por via de rotina, cabendo ao assistente demandar confirmacao solida da indicacao clinica subjacente baseada idealmente em niveis fidedignos de calcio ionizado colhidos recentemente ou calculo por calcio total corrigido por albumina. Alem da justificacao pautada no quadro clinico, soma se a obrigatoriedade da mais atenta e minuciosa analise pertinente aos ricos contextos de interações fisico quimicas documentadas ou supostas envolvendo possiveis incompatibilidades e risco agudo de precipitacao microcristalina no equipo vascular em

presença de outros potentes aditivos tais quais os sais de bicarbonato, sulfato e inúmeras fontes orgânicas ou inorgânicas contendo íons de fosfato.

FECHAMENTO DA PRESCRIÇÃO E TRIPLA CHECAGEM OBRIGATORIA. O cálculo efetivo e matemático pautado no volume final esperado do fluido primário ou básico restringe-se ao dimensionamento do total geral programado para o horário, devidamente subtraído das volumetrias aditivas da soma completa e irrestrita de todos os amplos aportes diluídos na solução. Em análise sistêmica e somatória, a totalidade e conjunção dos elementos constituintes que compõem o plano de hidratação e soroterapia devem atingir de forma cirúrgica e exata o volume final que havia sido planejado precocemente pelo executor médico. Ressalta-se enfaticamente e logicamente que nenhum volume aditivo particular resultante do fechamento pode vir a assumir ou configurar um estapafúrdio valor com sinal algebricamente negativo, caracterizando-o como iminente anomalia clínica obstrutiva. A margem global de flexibilidade tolerável estipulada e aceitável no intrincado processo de fechamento hídrico de vinte e quatro horas posiciona-se na restrita margem da ordem de limites situados em faixas sempre menores ou iguais ao ponto zero vírgula cinco mililitros absolutos, ou ainda alternativamente pautada de acordo com o pragmatismo condicionado pela graduação de resolução limitante encontrada e constatada na seringa de medição de pequenos volumes e aditivos disponível no ato do preparo farmacêutico na enfermagem. O ato gerencial referente ao processo de fracionamento ou à divisão temporizada do cronograma intrahospitalar que segmenta a solução líquida ao decorrer de ciclos em etapas logísticas ordenadas de administração intravenosa se fundamenta e utiliza predominantemente como base primordial a aferição da capacidade estática e do preenchimento máximo da bolsa infusional física, sendo esta lógica a responsável integral por determinar racionalmente não só o número preestabelecido de etapas necessárias, sejam elas estruturadas idealmente em 2, 3, 4, 6 ou até mesmo amplamente separadas em 8 amplas frações ao longo do dia intermitente, mas abrangendo do mesmo modo o cálculo para delimitar a duração temporal de cada ciclo e assegurar fidedignamente o correto fracionamento unilinear e proporcional de cada um dos componentes eletrolíticos e glicídicos e ativos infundidos no interior do reservatório plástico, impondo-se ademais à equipe assistencial o dever e a obrigação de sempre, e em todos os casos aplicáveis, recalcular de forma retrospectiva e sistemática os conteúdos remanescentes da última bolsa pendente logo após eventuais tomadas de decisão que envolvam quaisquer procedimentos de arredondamentos volumétricos efetuados nas frações preliminares, não poupando nenhum detalhamento acerca do consumo parcial residual documentado. Na continuidade do complexo rigor clínico exigido e sedimentado na prática de urgência e da terapia intensiva pediátrica, o intrincado fluxo assistencial impõe a execução mandatória, rígida e sem exceções documentais daquilo que se rotulou classificar de tripla checagem

compulsoria estruturada sobre três fortes vertentes axiais e integradas. A primeira destas etapas refere se invariavelmente a checagem matemática autônoma, cuja basilar função detém o encargo crucial de reconstruir as premissas primordiais e refazer a lapis ou intelecto os já efetuados e discutidos cálculos volumétricos baseados tradicionalmente no princípio lógico e pre-estipulado na regua histórica de cálculos diuturnos de Holliday Segar. Essa fase destina-se a assegurar que as somatorias hídricas totais, as restrições impostas por percentuais clinicamente elegíveis a partir das considerações diagnósticas vigentes, a determinação volumétrica crua de doses mínimas e os fluxos correntes definidores das vazões de infusões programadas tenham sido alcançadas através do pleno desenvolvimento autônomo, e sobretudo não viciado, de modo iminentemente independente das planilhas automáticas. Como subsequente componente processual intrínseco, desencadeia-se a compulsoria e analítica etapa pertinente a checagem de lógica inversa da ordem farmacêutica clínica. Sob a responsabilidade desta faceta fiscalizadora encontra-se a atribuição crucial de se reprocessar e fundamentalmente recalcular o estrito referencial posológico relativo a dose que está sendo real, física e veridicamente entregue pela veia e adentrando nos tecidos circulatórios íntimos, inferida sempre a partir e através da engenharia reversa executada sobre dados irredutíveis consistentes nas mensurações básicas e simples dos parâmetros de volume fracionado inserido perante a concentração fixa já documentada nos rótulos dos frascos originários inicialmente prescritos. Esta engenhosa auditoria possibilita essencialmente escrutinar e assim validar sem subterfúgios as margens tangíveis relativas aos índices aferidos nas taxas dinâmicas relativas de administração infusional de suporte glicosado, as composições salinas parciais estimadas segundo parâmetros de miliequivalentes administrados e absorvidos por cada litro do material preparado ou calculados pela carga dividida per capita segundo os limites pré-impostos e ditados categoricamente pelo quilograma, assim como ratificando integralmente a avaliação consolidada dos aportes cloretados totais contabilizados durante as flutuações e a incontestável validação sobre as apresentações efetivas disponíveis e reais. Finalizando e amarrando firmemente esse alicerce, tem-se incontestavelmente a proeminência insubstituível da imprescindível checagem propedéutica no aspecto primordial da lógica e do julgamento de matriz clínica. Sob a égide deste escrutínio holístico integral repousa o mandamento de promover irrestritamente uma extensa reavaliação de amplo espectro pautada no reestudo contínuo e exaustivo no que tange primordialmente à justificativa central que fundamenta a prescrição de todo suporte orgânico em comento. Exige-se confrontar incessantemente os perfis correspondentes à indicação base inicial diagnosticada e documentada versus os patamares da tonicidade fluida de fato resultante da mistura e imposta exogenamente sob as tenras e suscetíveis barreiras intra-endoteliais do arcabouço tecidual da criança em detrimento e considerando ainda de forma acoplada todos os reflexos pertinentes decorrentes de estados fisiológicos complexos intrínsecos de repercussão hídrica e hemodinâmica atrelados invariavelmente não somente a

constatação crua baseada perante as oscilações de cunho momentaneo atinentes aos estados de expansão ou retração de matriz estruturalmente volemica sistêmica ou intersticial. Torna se um dever profissional obrigatorio o escrutínio incansavel do emaranhado entrelaçamento provocado diante de todos os amplos e complexos fluxos e dos incessantes aportes ocorrentes de forma contigua e simultanea decorrentes de infusões acessórias alheias sob vias parenterais concomitantes. Nesta referida e abrangente constatação clinica de plausibilidade encontra se inserida e interligada a estrita auditoria continua sob dados pontuais a respeito do comportamento metabolico pautado sob variaveis como flutuação perigosa dos parâmetros capilares correspondentes à manutenção da meta de normalidade fisiologica restrita sobre as cifras quantitativas relativas a glicemia sanguinea global e dosagem e balanço quantitativo irrestrito do painel de sais corporais formadores de eletrólitos ionizados em transito fluido tissular capilar, cruzando e correlacionando diuturnamente as evidências fornecidas via acompanhamento laboratorial ou beira de leito relativas intimamente às performances diureticas e ritmos correspondentes as eliminações excretoras e as taxas correspondentes a filtragem do clearance e a efetividade na preservação do adequado status e estabilidade pautada em base na vitalícia preservação da inestimavel função integrativa do escopo do aparelho macro glomerular de cunho renal e sistêmico do ser humano tratado. O não cumprimento integral dessa vasta varredura não afasta em essência o mandamento primordial voltado ao balizamento dos possíveis agravos derivados diretamente pelas condições de inadequação relativas as características físico operacionais no arcabouço estrutural pautado pelo espectro perante as inserções ligadas a adequação das vias pautadas na alocação correspondente a suportes logísticos relativos e referentes aos distintos perfis dos dispositivos intravasculares cateterizados em forma periférica de baixo calibre em contraposição aos centralizados vasculares e da indispensabilidade concernente a validação correspondente ante preceitos atinentes a toda restrição liquida formalizada ativamente amparada nos registros correspondentes nos fluxos normativos restritos pautados nas vertentes do estipulado no protocolo clínico oficial institucional que avalia amplos componentes inseridos sob focos voltados na restrição hidrica mandatoria frente perigosos, severos e iminentes patamares associados na escala referente a escalada dos referenciados fatores sistemicos imbuídos nos espectros pertinentes associados a gravíssimos estados sistemicos e metabólicos relativos e pertinentes ante perigos de morbidade pautada intimamente ligada e conectada aos perigos oriundos das complicações agudas que derivam na escalada associativa ligada diretamente as condições perigosas iminentes atreladas intimamente sobre complicações e intercorrências secundarias e danosas ao organismo de modo global relativas a morbididades sob os múltiplos espectros concernentes atrelados frente a eventos e desfechos característicos nos parâmetros atinentes perante cenários referentes ante agudos de sobrecargas e edemas. Eventuais omissões ou a simples ausência incontestável de dados confiáveis sob qualquer uma, sob a mais tênue falha

evidenciada, e perante a menor deficiência pautada diante destes eixos de fiscalização fundamentais em inquestionável obrigatoriedade geram irrestritamente o dever irrevogável de efetuar no prontuário a marcação de documentação atestando sem margem para escusas uma condição inconteste e irrefutável de checagem estritamente incompleta pendente e reprovada pelo raciocínio da propedêutica e da terapêutica da propedêutica e reprovada nos crivos. E de forma irremediável e peremptória exigindo a obrigatória atitude correspondente em resultar na atitude irreversível do mais total bloqueio logístico inviabilizando na integralidade as emissões dos registros concernentes a autorização expressa em papel pautada atinente à documentação final na prescrição.

FORMATO DE ENTREGA DEFINITIVO E EVIDENCIAS. A resposta e o retorno prestado pelo assistente de calculos deve ser pautada e rigorosamente padronizada, sendo obrigatorio o fornecimento em sequência absoluta das seguintes e inegociáveis categorias estruturais sob a entrega integral correspondendo inicialmente as informações que estão alocadas diante o pilar correspondente de resultado principal contendo de forma explícita e clara todos os dados balizadores referenciados nos perfis intrínsecos de peso verídico anotado e checado referenciado em quilograma, somados e atrelados intimamente a estipulação etaria na idade precisa documentada nas fichas originais relativas ao cadastro admissional ambulatorial contiguo a explicitação pormenorizada pertinente a imperatividade clínica baseada e embasada unicamente pautada e referenciada sobre o motivo essencial ou seja frente a identificação do pilar correspondente ao fundamento da expressa indicação base da soroterapia infusional seguida imediatamente pela constatação e anotação fidedigna a respeito do parâmetro matemático que descreve a aferição estipulada pertinente ao referido limite da expansão global referente ao alvo máximo integral estabelecido para alcance em 100 por cento na totalidade pertinente sobre o volume teorico integral que delimita a fronteira a partir da aplicação irrestrita sobre regras consagradas e embasadas frente os manuais embasadores e em protocolos diuturnamente aplicados. Após, registra se a margem relativa no pilar referente a cotação no coeficiente relativo concernente na adoção clinica imposta no respectivo limite e taxa referente nos espectros contidos a imposição estipulada sob parâmetros aplicados concernente as deduções ligadas ativamente baseada na faixa e espectros e percentuais, contabilizando e documentando obrigatoriamente a exclusão logistica correspondente subtraindo os impactos e os balanços correspondentes ante somatórios de líquidos sob a denominação abrangente referente as rubricas correspondentes as fontes extrínsecas englobando as frações atreladas nos balanços e registros das anotações contidas a rubrica englobando volumes outros correspondentes abrangentes aos demais e outros exógenos e distintos aportes parenterais simultâneos de onde derivara inevitavelmente de modo inconteste nos fluxos matemáticos atinentes nas restrições no cômputo que

expressa invariavelmente de forma clara e cristalina a obtenção referencial da quantia e métrica residual limpa livre sob os referenciados aportes de onde origina e onde culmina o resultado e preceito pautado sobre volume de restrição pertinente ao registro e documentação efetiva relativa na documentação pautada perante volumes e referências relativas pertinentes atinentes nos estritos e definitivos residuais limites referenciados perante a exata final mensuração matemática limpa alocada referente às frações intravenosas do perfil residual final aferida na quantia e alocado em frações estipuladas do residual livre e pautado pela respectiva final estipulada da constante concernente as referidas margens horárias sob a taxa que expressa a estipulada vazão cronometrada em bombas de seringa precisas seguidas a posteriori das exigências da compulsoria anotação referenciando de modo explícito a rubrica denominada por calculo auditavel de maneira clara e transparente detalhando todos os pilares que evidenciem abertamente todas as engrenagens contidas nas respectivas e abertas equações aritméticas aplicadas associadas a citação mandatoria frente à referência alusiva pautada inquestionável concernente à documentação precisa relacionada a exata unidade paramétrica métrica adotada perante respectiva fórmula logarítmica seguida incontinenti sobre rubrica para citação extensa concernente à exata documentação pautada na indicação pormenorizada da efetiva composição hidroeletrolítica planejada estritamente sobre os patamares logísticos contidos perante os perfis temporais delimitando cronograma abrangendo rigorosamente alocado no balizamento na baliza demarcatória alocada referencial sob o tempo em limites em marcos temporais na janela do ciclo diário de 24 horas integrais documentando sem ambiguidades a compulsoriedade imposta na anotação descritiva pormenorizando de forma explicita detalhando todos os estritos itens que englobam a listagem dos frascos relativos às fontes das embalagens que descrevem precisamente as fontes das pautadas originais e originais apresentações comerciais disponíveis seguidas intrinsecamente do detalhamento claro pautando o registro da citação inquestionável sobre respectivos teores atrelados à final taxa das resultantes estipuladas e calculadas nos espectros em baliza pautada perante as efetivas margens referenciadas contidas nas concentrações efetivas ditadas atreladas a aferição referida relativa nas constatações e mensurações que compõem na fração correspondente sob resultantes em faixas restritas relativas de efetivas medidas atreladas atinentes finais e de caráter prontas e documentadas culminando no prosseguimento atinente mandatorio de estruturar na documentação estipulada o formato da matriz final alocada que se intitula perante a forma irreduzível definida correspondente referenciada sob o título pautado na elaboração e registro correspondente atinente da final e concreta prescrição de caráter já pronta pormenorizada de tal forma a englobar as minuciosas inserções relativas as devidas alusões explícitas sobre a totalidade pautada nos aditivos e sais atinentes pertinentes pautados perante elementos minerais e ativos pautados referentes inseridos sob englobados nos correspondentes compostos correspondentes a todos constituintes da mistura nos componentes fracionados devidamente citando

de forma irretocável todos os referenciados aspectos logísticos e temporais referentes pertinentes e correlatos a documentações e pormenorizações de ordem concernente referentes às fundamentais vias atinentes à indicação correspondentes ante orientações alocadas na seleção e determinação restrita das respectivas e selecionadas seguras vias atinentes e delimitadas sob fracionamentos contidos em divisões delimitando as margens logísticas em referenciadas em fracionamento atrelado sob etapas sucessivas e devidamente divididas. O passo seguinte consiste na irrevogável elaboração da referenciada e documentada da rubrica alocada denominada e conhecida na literatura pela designação inerente à etapa compulsoria estruturada correspondente de modo inegociável na referida anotação atrelada na documentação atinente em pormenorizada da reavaliação matemática contida perante e chamada no formato contendo referências associadas pertinente atrelada em checagem referenciada sobre rubrica que denomina a chamada e irrevogável respectiva checagem sob a modalidade estruturada pautada em base na propedêutica e formula de matriz farmacêutica e aritmética baseada em logística correspondente sobre retrocesso da logística reversa evidenciando enfaticamente com clareza o detalhamento das margens alocadas nas rubricas associadas atinentes relativas em documentação sobre parâmetros atrelados referentes pertinentes referentes sobre resultados oriundos da checagem comprovando a verificação alusiva ao cômputo da constatação documentada atrelada à respectiva posologia exata e aferida sob dose da substância ativamente sob verídica referenciada e alocada constatação efetiva que atesta a entrega intravenosa concluída referenciando de modo irrepreensível com todas pormenorizadas e irrecorríveis pautadas associadas aferições matemáticas concernentes as constatações inerentes baseadas referentes e atreladas nos balanços alusivos relativas a margem de efetividades nas constatações em análises e averiguações atinentes sob as margens e níveis em documentação atreladas sob parâmetros pertinentes nas checagens pautadas sob referências pautadas nas chamadas secundarias documentações. Encerra se a estruturação com a rubrica correspondente das pautas voltadas na vigilância e em rotinas contidas em alocação referenciada referente à manutenção atinente pautada na rubrica chamada sob matriz correspondente em anotações de logística em documentação clínica na referência chamada concernente em monitorização estrita detalhada com referências a parâmetros em medição pautada em documentação e verificação relativas nos protocolos atinentes sob parâmetros associados perante o controle em rotina referente e estipulada balizada na mensuração de balanço hidrico geral e a constante constatação propedêutica voltada na busca e controle sob margem e perfil focado diante a monitorização pautada focada em achados relativos sobre vigilância na constatação correspondente diante das ameaças referentes a sinais propedêuticos alusivos atinentes perante cenários referentes atrelados perante o contexto de emergência clínica na forma contida em sintomas associativos correspondentes atinentes a quadros de evolução pertinente em alarmes e risco iminente de evolução

sob constatação associativa referente em evolução correspondente a quadros e espectros associados e caracterizados em piores e perigosos iminentes sintomas e sinais de alarme e instabilidade sistêmica finalizando perante a imperativa inclusão relativa atinente no campo logístico alusivo perante o preenchimento na área respectiva na referência final estipulando parâmetros balizados referentes a rubrica designada alocada no campo para constatação das respectivas constatações do término e fim de etapas relativas e atreladas pautadas na determinação balizadora do atestamento de constatação no balizamento do preenchimento referenciado no status em constatação pautada relativa e referenciada sobre indicação de atestamento relativo nos âmbitos atrelados no atestamento referente à conclusão pautada relativa atinente nas referidas matrizes atreladas à chancela na execução documentada pautada relativas frente ao atestamento perante encerramento das pertinentes checagens obrigatórias pautando de forma final a rubrica relativa e referente contida no balizamento atrelado perante pormenorização e documentação alocada em constatação das referidas citações pertinentes ligadas estritamente relativas as respectivas teses iniciais relativas pautadas na adoção referenciada de parâmetros inseridos em teses nas premissas adotadas e incorporadas baseadas estritamente perante a indicação atrelada e balizada nas respectivas bases com alocação focada no preceito alusivo a citação referente com a citação fidedigna atinente pautada na referenciada embasamento ancorada baseadas fundamentadas estritamente referenciada perante citação atinente às fontes devidamente validadas documentadas e rigorosamente fundamentadas. Não se deve jamais emitir a prescrição pronta havendo incertezas sobre o peso ou unidade de medida, recém nascidos fora de protocolo, volumes irreais ou negativos, calculos não exatos, concentrações não checadas, uso de potassio sem avaliação renal confiável, correções agudas de sodio sem protocolo ou incompatibilidade de acesso, devendo o sistema emitir alerta critico, entregar apenas o segmento seguro e suspender a finalização ate que o humano resolva a pendencia. Os materiais fornecidos paralelamente podem conter formulas uteis, macetes, exemplos e ate mesmo erros, de modo que cabe ao profissional corrigir e explicar qualquer divergencia detectada. A segurança clinica do paciente, o rotulo da medicação, a evidencia cientifica atual e o protocolo institucional devem sempre prevalecer sobre qualquer recomendação e orientar as diretrizes. Todo calculo clinico pediatrico e real em vigencia requer e depende fundamentalmente da analise minuciosa fundamentada estritamente e balizada e alocada pautada embasada pautada pautada atinente à documentada pesquisa diuturna em manuais e atualizadas referências bibliográficas referenciadas em protocolos e nas documentações originarias balizadoras inseridas diante manuais atinentes às fontes fidedignas chanceladas referenciadas oriundas e sediadas nos protocolos atinentes sob as margens contidas perante as secretarias e diretrizes oriundas nos níveis de instâncias sob governanças de protocolos normativos referenciados no espectro de esferas das respectivas governanças nas diretrizes correspondentes sob estaduais chanceladas chancelas nas

orientações correspondentes contidas em manuais originários da tutela pautada oriundas nas matrizes relativas correspondente sociedades científicas reconhecidas nacionalmente nas margens e esferas atinentes ligadas às instâncias balizadas voltadas unicamente e referentes e ligadas e restritas nas competências referentes no âmbito das especializadas associações atuantes e pautadas frente diretrizes estritas no espectro correspondente à tutela em chancelas de órgãos pautados no preceito associado a pediatria e neonatologia balizadas com consulta rotineira frente bulas e na vasta documentação fundamentada pautada nos compêndios referentes a estudos literários oriundos e referentes e baseados pautados estritamente na fundamentação associada nos estritos limites embasados nos conteúdos referenciados e relativos correspondentes aos pilares de evidências fidedignas ligadas aos chamados primários relatórios e balizados e referenciados pautados vigentes. Este sistema opera estritamente como ferramenta de apoio à decisão, ressaltando se que eletrólitos concentrados exigem dupla checagem humana e completamente independente sempre precedendo de imediato todo tipo correspondente perante de preparo logístico balizado na respectiva efetiva e pautada final e irretocável conduta médica atinente ligada em final subsequente via intravenosa direta ou bomba pautada e na final referenciada administração na veia e corpo do frágil correspondente e vulnerável infante paciente em observação.